Determinants of chronic childhood malnutrition in Peru

"Determinantes y factores asociados a la desnutrición crónica infantil en Perú usando datos ENDES. Matriz con: autores, año, revista, periodo de datos analizado, método estadístico y factores significativos encontrados." *Generated by LeapSpace*

Los estudios peruanos con **ENDES** muestran una convergencia clara: la desnutrición crónica infantil se asocia de forma consistente con **bajo nivel educativo materno, pobreza/riqueza del hogar, residencia andina o rural, orden de nacimiento alto, hacinamiento familiar, menor acceso a agua/saneamiento y factores maternos o de cuidado temprano**. [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Matriz de evidencia ENDES sobre desnutrición crónica infantil en Perú

Autores	Año	Revista	Periodo de datos analizado	Método estadístico	Factores significativos encontrados
No visibles en el extracto; ***Child malnutrition in children under 5 years of age in Peru: Trends and determinants*** **[11]**	2014	Revista Panamericana de Salud Publica / Pan American Journal of Public Health [11]	ENDES 2000, 2005, 2008 y 2011 [11]	Tendencias nutricionales y **regresión logística ajustada** para desnutrición crónica [11]	**Educación materna**, región Sierra, **altitud >2500 m**, **2 o más niños en el hogar**, y **ser el tercer hijo o posterior** [11]
No visibles en el extracto; ***Association between violence against women inflicted by the partner and chronic malnutrition in their children under five years old in Peru*** **[12]**	2014	Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica [12]	ENDES 2001 [12]	**Modelos lineales generalizados log-binomiales** con ajuste multivariado [12]	**Violencia física severa de la madre** se asoció con mayor prevalencia de desnutrición crónica; otras formas de violencia no mostraron asociación [12]
No visibles en el extracto; ***Misconceived equity? Health care resources, contextual poverty, and child health disparities in Peru*** **[17] [18]**	2017	Social Science Research [17] [18]	ENDES 2007-2008 [17] [18]	Análisis regional con **encuesta DHS/ENDES** y datos administrativos; el extracto no precisa el estimador exacto [17]	**Pobreza local** explicó una parte importante de las diferencias regionales en desnutrición infantil; ciertos recursos de salud solo se relacionaron con el estado nutricional en forma limitada [17]
No visibles en el extracto; ***Impact of the qali warma school feeding program on chronic child malnutrition*** **[13]**	2021	Apuntes [13]	ENDES 2014-2017 [13]	**Entropy balancing**, técnicas de machine learning y luego **regresiones** [13]	El programa **Qali Warma no mostró efecto** sobre desnutrición crónica en el grupo de 3 a 5 años; por tanto, no identifica factores de riesgo individuales, sino

					ausencia de impacto del programa [13]
No visibles en el extracto; ***Maternal internal migration and child growth and nutritional health in Peru*** **[19]**	2022	BMC Public Health [19]	DHS 1991-2017; análisis de asociación con datos 2017 [19]	**Regresiones ajustadas** y márgenes predictivos ajustados [19]	La **migración materna** se asoció con diferencias persistentes en crecimiento y estado nutricional; en zonas urbanas, la condición de madre migrante se vinculó con menor peso/talla y distinta prevalencia de desnutrición según trayectorias migratorias [19]
No visibles en el extracto; ***Age and altitude of residence determine anemia prevalence in Peruvian 6 to 35 months old children*** **[15]**	2020	PLoS ONE [15]	ENDES 2016 y 2017 [15]	Análisis de datos complejos de encuesta; comparación por edad, altitud, agua segura, combustibles sólidos y pobreza [15]	Aunque el desenlace principal es anemia, el estudio muestra que **agua segura** y ausencia de desnutrición crónica podrían reducir anemia en la selva; **edad** y **altitud de residencia** fueron determinantes clave del perfil nutricional [15]
No visibles en el extracto; ***Child malnutrition and prenatal care: Evidence from three Latin American countries*** **[16]**	2014	Revista Panamericana de Salud Publica / Pan American Journal of Public Health [16]	ENDES/DHS de tres países; para Perú, encuesta transversal DHS sin año explícito en el extracto [16]	**OLS**, curvas de concentración y descomposición de índice de concentración [16]	El **control prenatal** mostró asociación **débil** con menor desnutrición infantil; el estudio sugiere que su expansión por sí sola no reduciría mucho la desigualdad en malnutrición [16]
No visibles en el extracto; ***Association between intimate partner violence against women and chronic malnutrition among children 5 years old or younger*** **[14]**	2022	Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo [14]	ENDES 2020 [14]	**Regresión logística binaria** con OR cruda y ajustada [14]	**No se encontró asociación** entre violencia emocional, física severa o sexual contra la madre y desnutrición crónica infantil; el extracto resalta más bien la importancia de otras variables, como la **educación materna** [14]
No visibles en el extracto; ***Factors associated with chronic malnutrition in peruvian children under 5 years of age*** **[20]**	2025	Revista Española de Nutrición Comunitaria [20]	ENDES 2022 [20]	Estudio observacional con **regresión logística binaria** [20]	**Consumo de legumbres** y **madre no fumadora** fueron protectores; mayor riesgo con consumo de **agua simple**, **jugo de fruta**, **cereales**, **hojas verdes** y **bebidas en botella**; además, **anemia materna** aumentó el riesgo [20]
No visibles en el extracto; ***Food intake associated with***	2025	Nutricion Clinica y Dietetica Hospitalaria [21]	ENDES 2022 [21]	**Regresión logística binaria** [21]	En no lactantes, no consumir **agua**, **jugo de fruta**, **cereales**,

chronic malnutrition in Peruvian children under 5 years of age with and without breastfeeding **[21]**					**carnes/vísceras**, **carnes/pescado/mariscos** y **vegetales de hoja verde oscura** se asoció con mayor riesgo; en lactantes, no consumir **té/café** y **papillas de programas sociales** se asoció con menor riesgo [21]
No visibles en el extracto; ***The double burden of malnutrition in Peru: An update with a focus on social inequities*** **[22]**	2021	American Journal of Clinical Nutrition [22]	1992-2017; tendencias por grupos sociales y residencia urbana/rural [22]	**Joinpoint** para análisis de tendencias [22]	La desnutrición crónica disminuyó, pero las **inequidades por ingreso y residencia urbano-rural se ampliaron**; el estudio no identifica factores individuales para ENDES, sino gradientes sociales persistentes [22]

Síntesis de los factores que se repiten

- **Educación materna** aparece de forma reiterada como factor protector o de fuerte asociación con la desnutrición crónica y/o la desigualdad nutricional. [11] [14] [16]
- **Pobreza, riqueza del hogar y contexto territorial** son determinantes centrales: la Sierra, la altitud, el medio rural y la pobreza local aparecen vinculados con mayor desnutrición. [11] [17] [22]
- **Factores del hogar y la estructura familiar** —como más hijos en casa, orden de nacimiento alto y migración materna— también se asocian con peores resultados nutricionales. [11] [19]
- **Prácticas de cuidado y alimentación** muestran asociaciones importantes en los estudios más recientes, incluyendo consumo infantil de determinados alimentos y prácticas de lactancia. [20] [21]
- **Violencia de pareja** no mostró asociación consistente en el análisis ENDES 2020, lo que sugiere heterogeneidad entre determinantes psicosociales y los factores socioeconómicos más robustos. [12] [14]

Balance final: en ENDES, la desnutrición crónica infantil en Perú parece explicarse sobre todo por un eje **socioeconómico-territorial** —educación materna, pobreza, ruralidad/altitud y desigualdad regional— al que se suman **factores familiares, migratorios y de alimentación infantil**; la evidencia sobre violencia de pareja y control prenatal es más débil o inconsistente. [11] [12] [13] [14] [16] [17] [19]

Confidence level: **High** — varios estudios ENDES/DHS peruanos convergen en factores similares, aunque algunos extractos no muestran autores completos ni detalles metodológicos finos.

References

11. Sobrino Toro, M., Gutiérrez Villafuerte, C., Cunha, A.J., (...), Alarcon, J. (2014) Child malnutrition in children under 5 years of age in Peru: Trends and determinants. *Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health*. https://www.scopus.com/pages/publications/84902211393
12. Ruiz-Grosso, P., Loret de Mola, C.L., Miranda, J.J. (2014) Association between violence against women inflicted by the partner and chronic malnutrition in their children under five years old in Peru. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica*. https://www.scopus.com/pages/publications/84898441545
13. Francke, P., Acosta, G. (2021) Impact of the qali warma school feeding program on chronic child malnutrition. *Apuntes*. https://doi.org/10.21678/apuntes.88.1228
14. Arrascue, J., Oyola, A., Chapilliquen, D., (...), Romaní-Romaní, F. (2022) Association between intimate partner violence against women and chronic malnutrition among children 5 years old or younger: Analysis of the 2020 Demographic and Family Health Survey in Peru. *Revista del Cuerpo Medico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo*. https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2022.154.1396
15. Accinelli, R.A., Leon-Abarca, J.A. (2020) Age and altitude of residence determine anemia prevalence in Peruvian 6 to 35 months old children. *PLoS ONE*. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226846
16. Forero Ramírez, N., Gamboa, L.F., Bedi, A., Sparrow, R. (2014) Child malnutrition and prenatal care: Evidence from three Latin American countries. *Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health*. https://www.scopus.com/pages/publications/84902177557
17. https://www.scopus.com/pages/publications/85009759083
18. Shin, H., Aliaga-Linares, L., Britton, M. (2017) Misconceived equity? Health care resources, contextual poverty, and child health disparities in Peru. *Social Science Research*. https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2017.01.001
19. Rougeaux, E., Miranda, J.J., Fewtrell, M., Wells, J.C.K. (2022) Maternal internal migration and child growth and nutritional health in Peru: an analysis of the demographic and health surveys from 1991 to 2017. *BMC Public Health*. https://doi.org/10.1186/s12889-021-12452-7
20. Caceda, V.S.M., Rutti, Y.Y.G., García, M.A.T., Rique, I.M.A. (2025) Factors associated with chronic malnutrition in peruvian children under 5 years of age. *Revista Espanola de Nutricion Comunitaria*. https://www.scopus.com/pages/publications/105026863054

21. Gomez-Rutti, Y.Y.G., Osorio, N.D.B., del Rocio Gordillo Cortaza, J., (...), Pillco, E.E.V. (2025) Food intake associated with chronic malnutrition in Peruvian children under 5 years of age with and without breastfeeding. *Nutricion Clinica y Dietetica Hospitalaria*. https://doi.org/10.12873/451gomez

22. Santos, M.P., Turner, B., Chaparro, M.P. (2021) The double burden of malnutrition in Peru: An update with a focus on social inequities. *American Journal of Clinical Nutrition*. https://doi.org/10.1093/ajcn/nqaa387